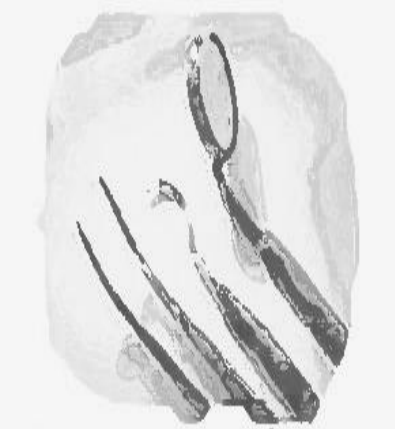
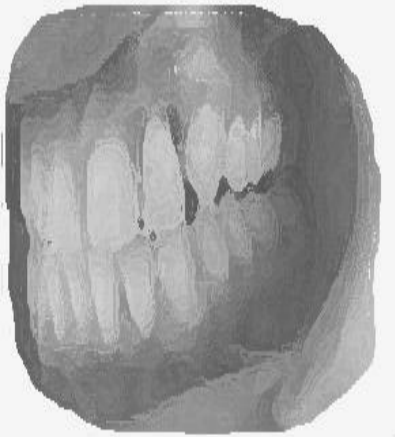


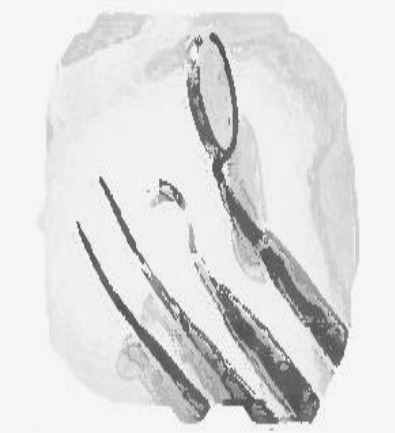




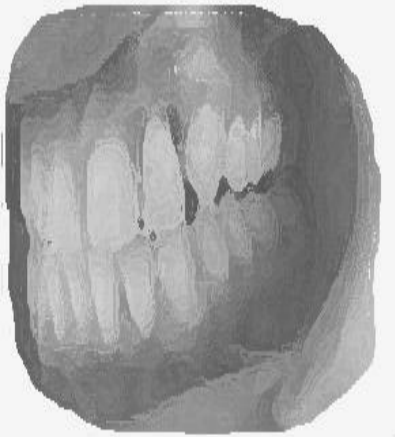
Epidemiologia das Condições Periodontais











Epidemiologia das Condições Periodontais

O **objetivo** desta apresentação é abordar a epidemiologia das doenças e condições periodontais de maior interesse, os índices mais utilizados em estudos epidemiológicos e o quadro nacional de agravos periodontais

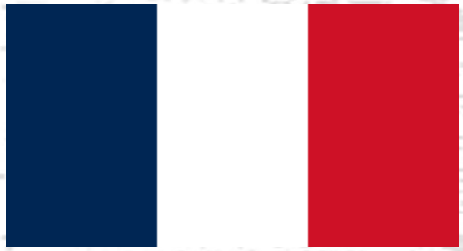
Atenção à saúde do idoso

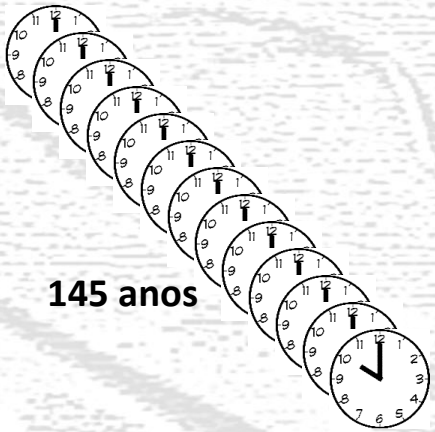
ESTADÃO Notícias & Editorias Ver & Ouvir Dia a dia Produtos Buscar... ASSINE ESTADÃO

‘Vamos envelhecer em 19 anos o que a França envelheceu em 145, mas, aqui, o velho é sempre o outro’

1850 – 10% Idosos

1995 – 20% Idosos





145 anos





19 anos

2010 – 10% Idosos

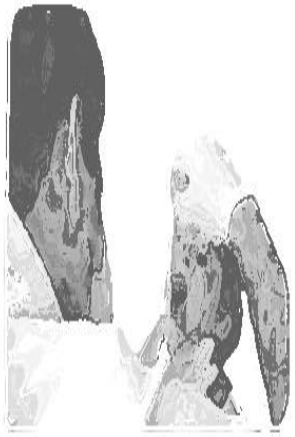
2029 – 20% Idosos

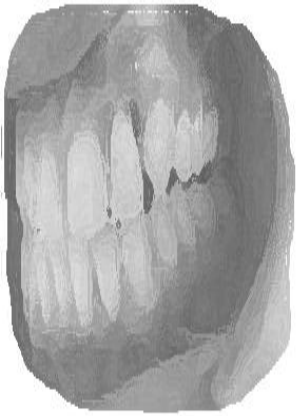
Atenção à saúde do idoso

Número de profissionais por especialidade			
Acupuntura	502	Odontologia hospitalar	2767
Cirurgia e traumatologia buco maxilo faciais	7645	Odontologia legal	963
Dentística	7059	Odontologia para pacientes com necessidades especiais	900
Disfunção temporomandibular e dor orofacial	1631	Odontopediatria	9900
Endodontia	19132	Ortodontia	32106
Estomatologia	1113	Ortopedia funcional dos maxilares	1733
Harmonização orofacial	4035	Patologia oral e maxilo facial	429
Homeopatia	225	Periodontia	10762
Implantodontia	21.135	Prótese buco maxilo facial	69
Odontogeriatria	277	Prótese dentaria	14004
Odontologia do esporte	44	Radiologia odontológica e imagiologia	5745
Odontologia do trabalho	1132	Saúde coletiva	2613

- A Harmonização Orofacial foi reconhecida como especialidade odontológica pelo Conselho Federal de Odontologia (CFO) em 2019, por meio da Resolução CFO 198/2019.
- O Brasil foi o primeiro país do mundo a considerar a Odontogeriatria como uma especialidade odontológica, a partir de uma resolução do Conselho Federal de Odontologia (CFO) em 2001.





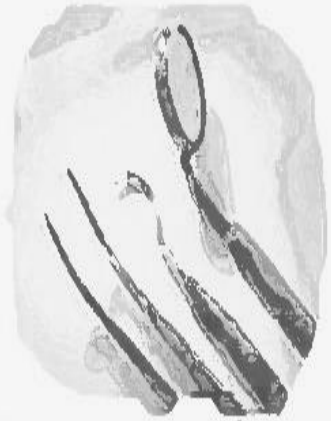


Epidemiologia das Condições Periodontais

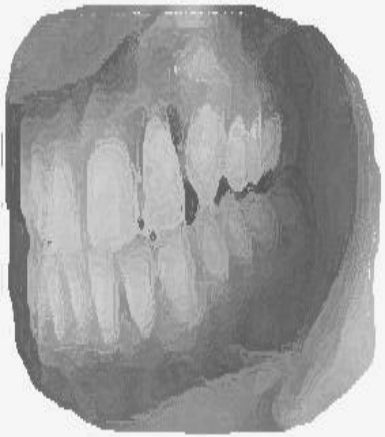
A expressão "Doença Periodontal" é comumente utilizada para representar o grupo de patologias que afetam os tecidos periodontais de proteção (gengiva) e inserção (osso alveolar, ligamento periodontal e cemento)

- Gengivite – sinais da inflamação restritos à gengiva.

- Periodontite – quando a inflamação causa danos ao osso alveolar, cemento e ligamento periodontal.







Epidemiologia das Condições Periodontais

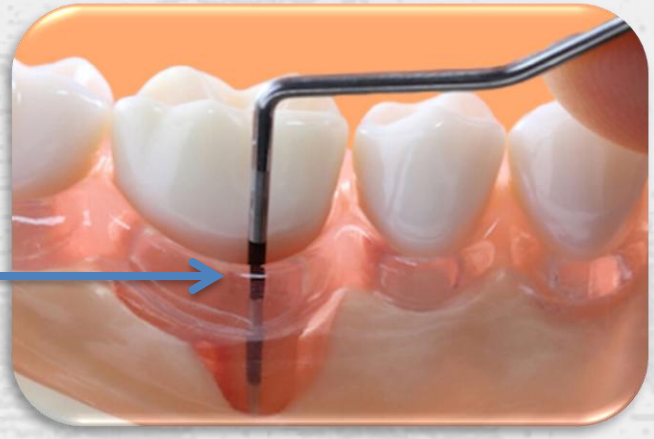
Gengivite

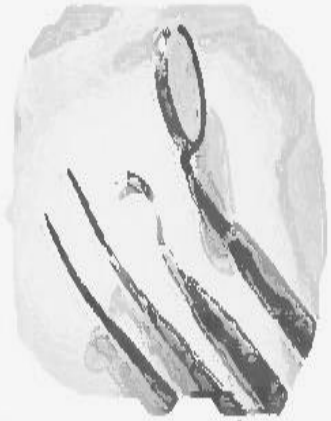


Periodontite

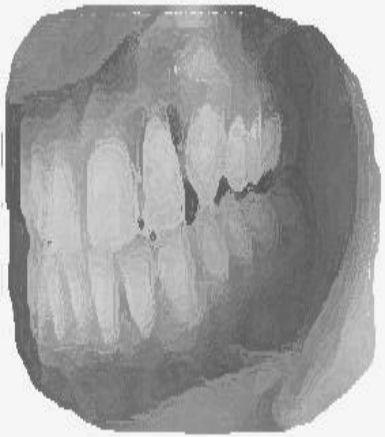


- O que distingue clinicamente essa duas condições é a presença de bolsa periodontal









Epidemiologia das Condições Periodontais

A doença periodontal é mais prevalente em adultos e idosos e traz consequências no que refere:

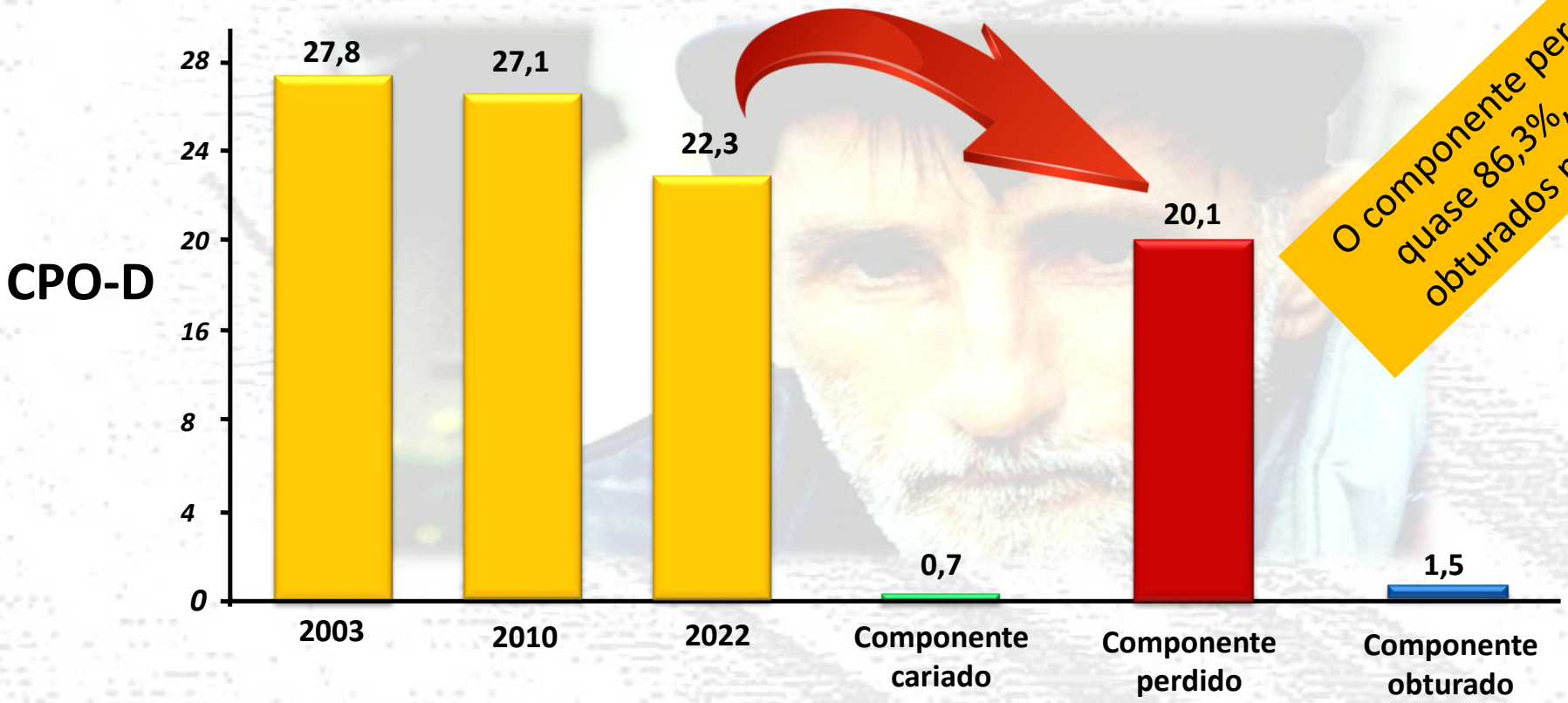
- **Dor**
- **Perda dentária**
- **Absenteísmo no trabalho**
- **Problemas de socialização**
- **Dificuldades nutricionais**
- **Infecções sistêmicas**



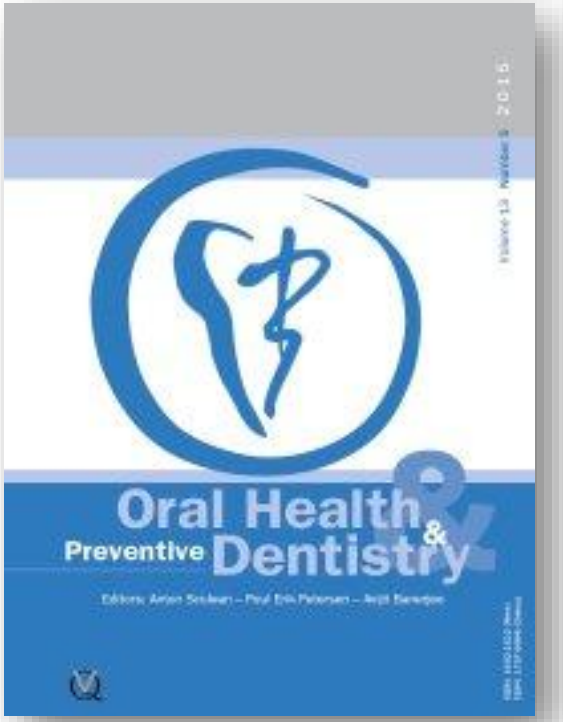
Epidemiologia das Condições Periodontais

Média do CPO e respectivos componentes segundo grupo etário 65 a 74 anos de idade. Brasil, 2022.

Distribuição dos componentes



Fonte: Ministério da Saúde, 2025



Primary Reason for Tooth Extraction in a Brazilian Adult Population

Renata Cimões Jovino-Silveira[a]/Arnaldo de França Caldas Júnior[b]/
Eliane Helena Alvim de Souza[b]/Estela Santos Gusmão[c]

Purpose: To identify the primary reasons for tooth extraction in a Brazilian adult population.

Materials and Methods: Interviews and oral examinations were conducted with 466 subjects aged from 18-76 years in the city of Maceió, Brazil. Frequency distributions, means and medians were calculated and the chi-square test was used to determine the level of significance. A logistic regression model was used to evaluate the variables associated with reasons for tooth extraction.

Dos 466 extrações, realizados em sujeitos de 18 a 76 anos de idade, 295 (63,3%) foram devido a cárie dentária, 61 (13,1%), devido à doença periodontal, 56 (12,0%) por motivos ortodônticos, 32 (6,9%), a pedido do paciente,

15 (3,2%) por motivos pré-protéticas, quatro (0,9%), devido à pericoronitis, dois (0,4%), devido ao trauma e um (0,2%) por outros motivos.





INTERNATIONAL DENTAL JOURNAL 72 (2022) 52–57

Scientific Research Report

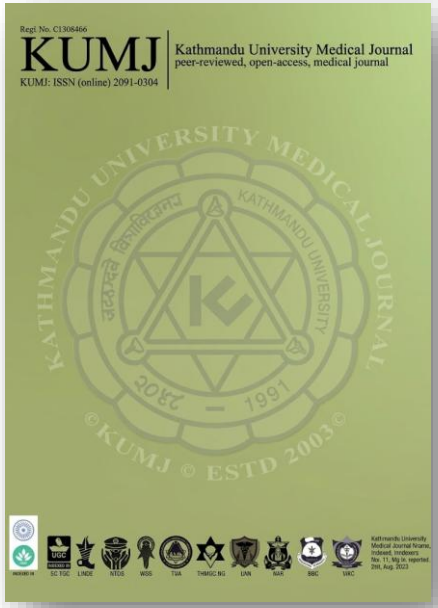
Reasons for Tooth Removal in Adults: A Systematic Review

Dyonne L.M. Broers [a*], *Leander Dubois* [b,c], *Jan de Lange* [d,e], *Naichuan Su* [f], *Ad de Jongh* [g,h,i,j,k]

Três estudos (totalizando 4396 extrações) puderam ser incluídos para a avaliação

CONCLUSION:

As indicações relatadas para extração dentária incluíram cárie com a proporção de todas as extrações variando de 36,0% a 55,3%, periodontite de 24,8% a 38,1%, trauma de 0,8% a 4,4%, doença periapical de 7,3% a 19,1%, ortodontia de 2,5% a 7,2% e outros motivos de 4,5% a 9,2%.



Kathmandu University Medical Journal (2009), Vol. 7, No. 1, Issue 25, 59-62

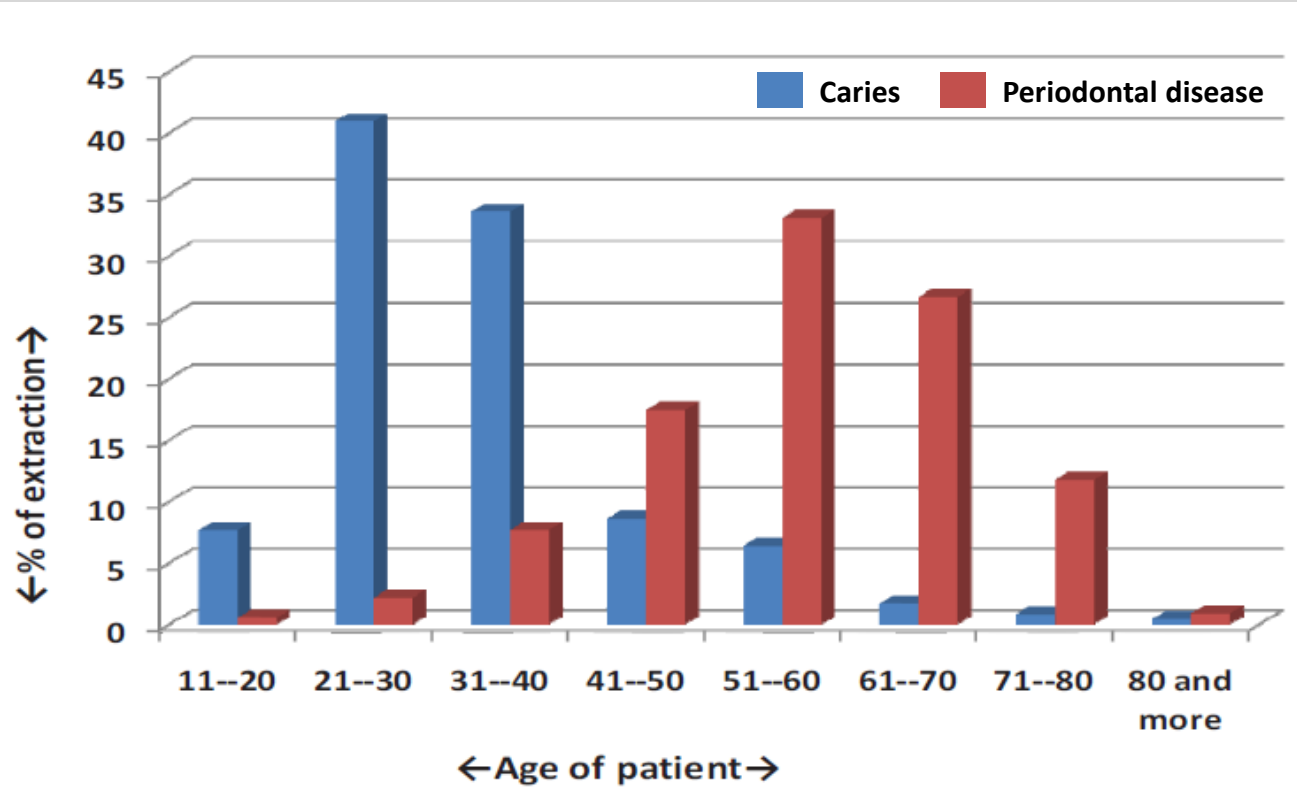
Original Article

The pattern of tooth loss due to dental caries and periodontal disease among patients attending dental department (OPD), Dhulikhel Hospital, Kathmandu University Teaching Hospital (KUTH), Nepal

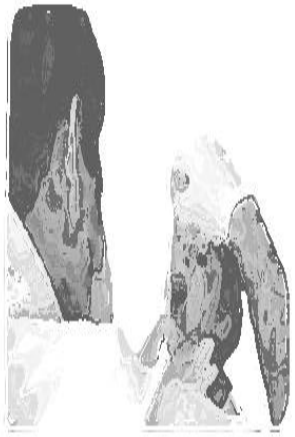
Upadhyaya C[1], Humagain M[2]

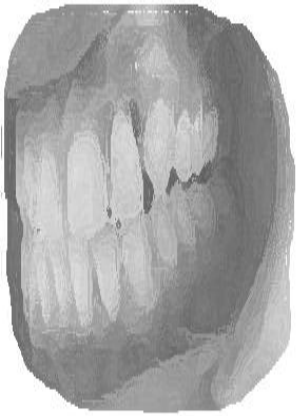
[1,2]Lecturer, Department of Dentistry, Dhulikhel Hospital, Kathmandu University Teaching Hospital (KUTH), Dhulikhel, Nepal

Um total de 626 pacientes atendidos no ambulatório do departamento de Odontologia do Hospital Dhulikhel foram incluídos no estudo durante um período de seis meses.









Epidemiologia das Condições Periodontais

Índices mais utilizados em pesquisas epidemiológicas sobre condições periodontais

- Índice de Higiene Oral Simplificado
- Índice de Sangramento após Sondagem
- Índice Periodontal Comunitário
- Índice de Perda de Inserção

Índice de Higiene Oral Simplificado – IHO-S

GREEN e VERMILLION (1964)

- Para observarmos os valores do IHO-S é necessário utilizar substâncias evidenciadoras de placa bacteriana;
- Verificar a eficiência de métodos de escovação;
- Verificar os efeitos de programas de educação para a saúde bucal;
- No IHO-S examinamos apenas algumas superfícies específicas de dentes selecionados e, segundo os autores, se nestas superfícies encontrarmos uma certa quantidade de placa é sinal que nas demais também a encontraremos.

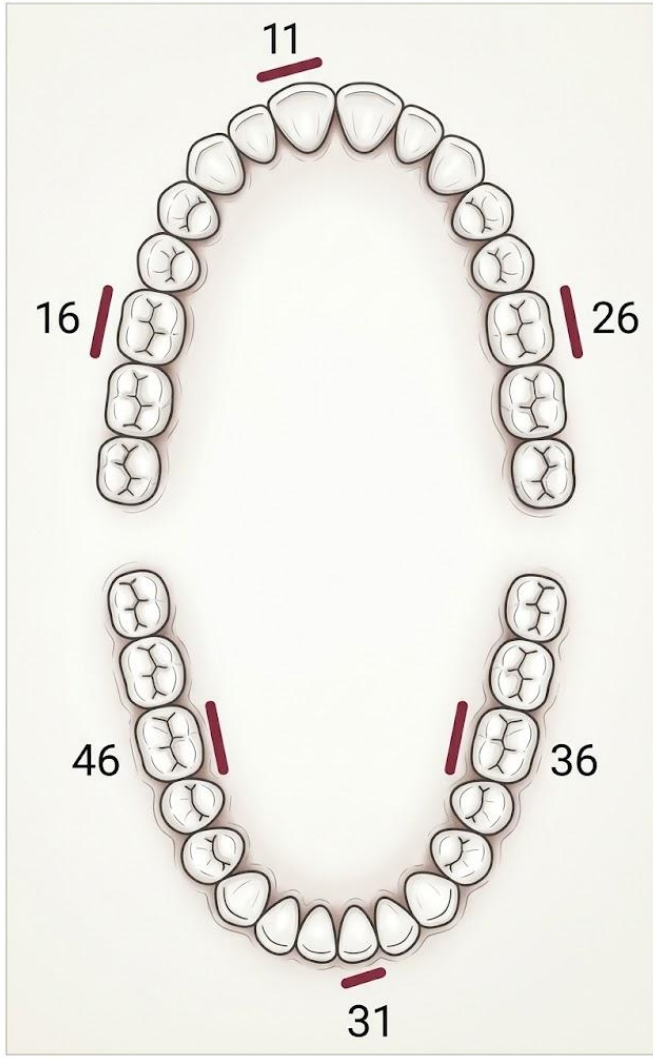




Índice de Higiene Oral Simplificado – IHO-S

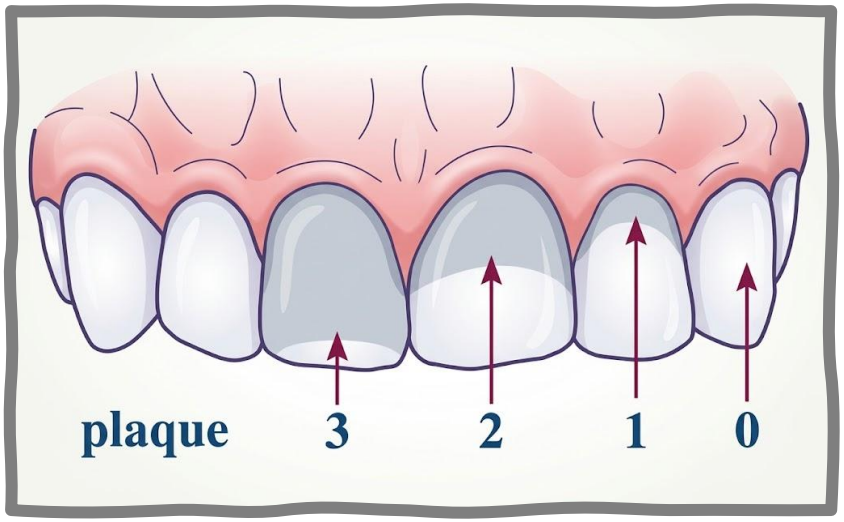
GREEN e VERMILLION (1964)

- Este índice mede a área da superfície vestibular dos dentes 11, 31, 16, 26 e a área lingual dos dentes 36 e 46 cobertas por placa e cálculos.
- Quando este dente estiver ausente poderá ser substituído por um adjacente.
- Cada superfície recebe separadamente um código de 0 a 3 para placa e para cálculo.
- Há um sub-índice para placa e outro para o cálculo, sendo o IHO-S a soma dos dois.
- Apenas os dentes totalmente erupcionados são considerados



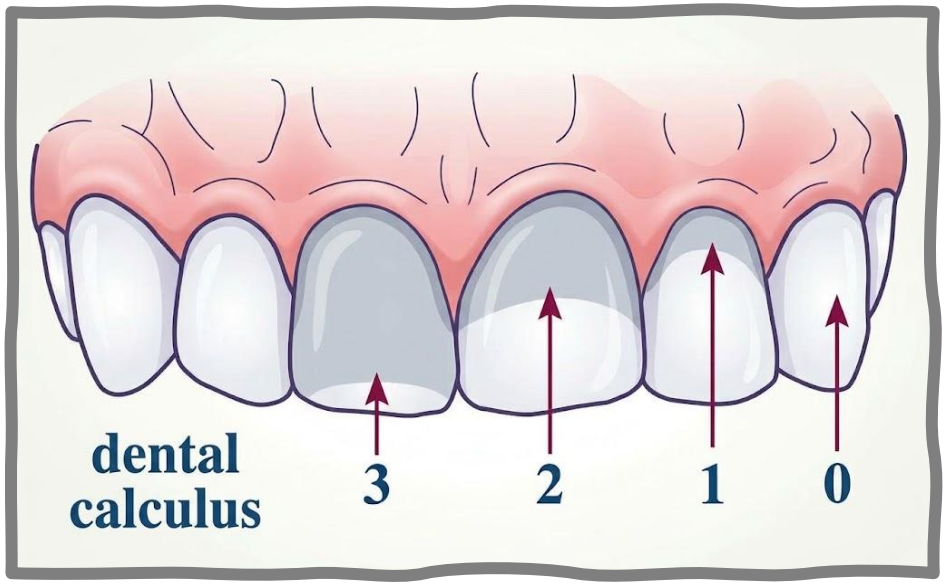
Índice de Higiene Oral Simplificado – IHO-S

Registro do Índice de Placa	
Código	**Definição**
0	Inexistência de placa
1	placa supra gengival que não cobre mais que 1/3 da superfície exposta do dente
2	placa supra gengival cobrindo mais que 1/3 mas não mais que 2/3 da superfície do dente
3	placa supra gengival cobrindo mais que 2/3 da superfície do dente
x	para dente índice e substituto inexistente





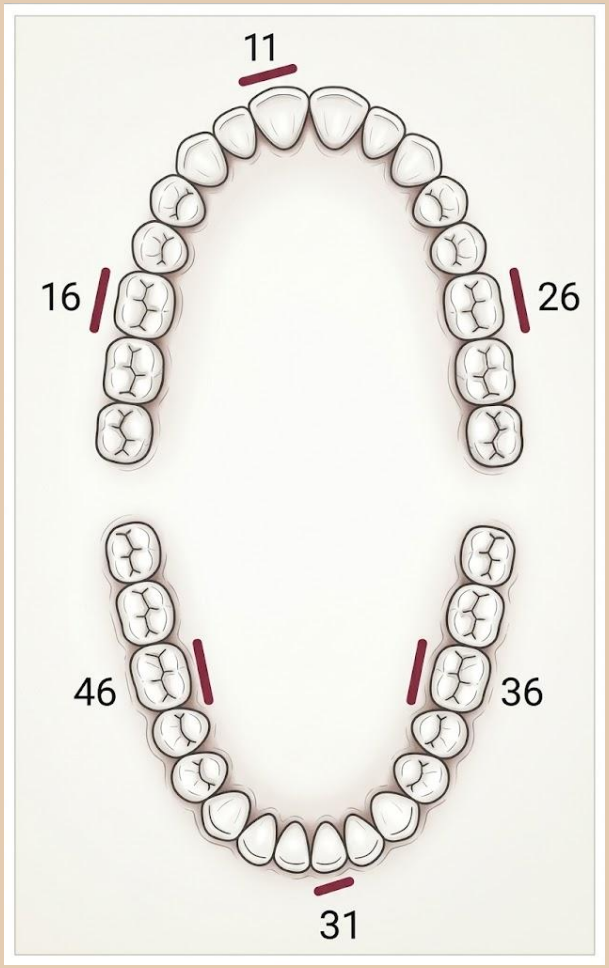
Índice de Higiene Oral Simplificado – IHO-S

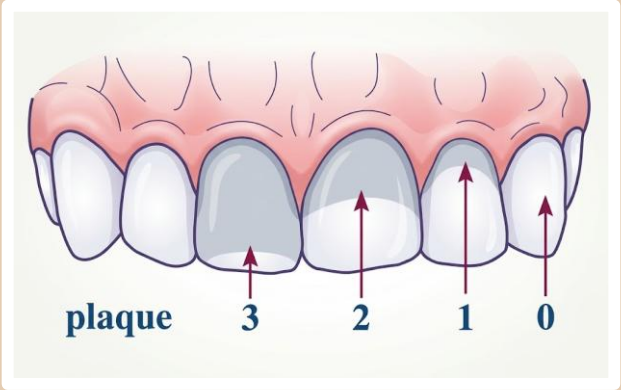




Registro do Índice de Cálculo	
Código	**Definição**
0	**Inexistência de cálculo**
1	**cálculo supra gengival que não cobre mais que 1/3 da superfície exposta do dente**
2	**cálculo supra gengival cobrindo mais que 1/3 mas não mais que 2/3 da superfície do dente**
3	**cálculo supra gengival cobrindo mais que 2/3 da superfície do dente**
x	**para dente índice e substituto inexistente**

Índice de Higiene Oral Simplificado – IHO-S





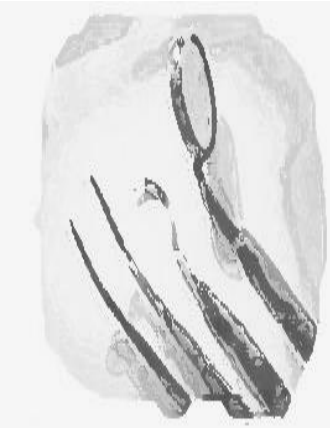
Índice de Placa = $\frac{\text{soma dos códigos de cada dente}}{\text{n.º total de dentes examinados}}$

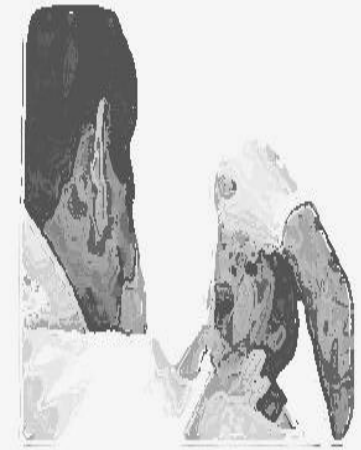
Índice de Cálculo= $\frac{\text{soma dos códigos de cada dente}}{\text{n.º total de dentes examinados}}$

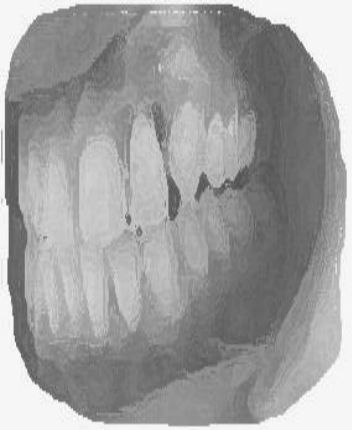
Resultado

Índice de Placa + Índice de Cálculo = IHO-S

- **0 a 1** → **HIGIENE ORAL SATISFATÓRIA**
- **1,1 a 2** → **REGULAR**
- **2,1 a 3** → **DEFICIENTE**
- **3,1 em diante** → **HIGIENE ORAL MUITO RUIM**







Índice de Higiene Oral Simplificado – IHO-S

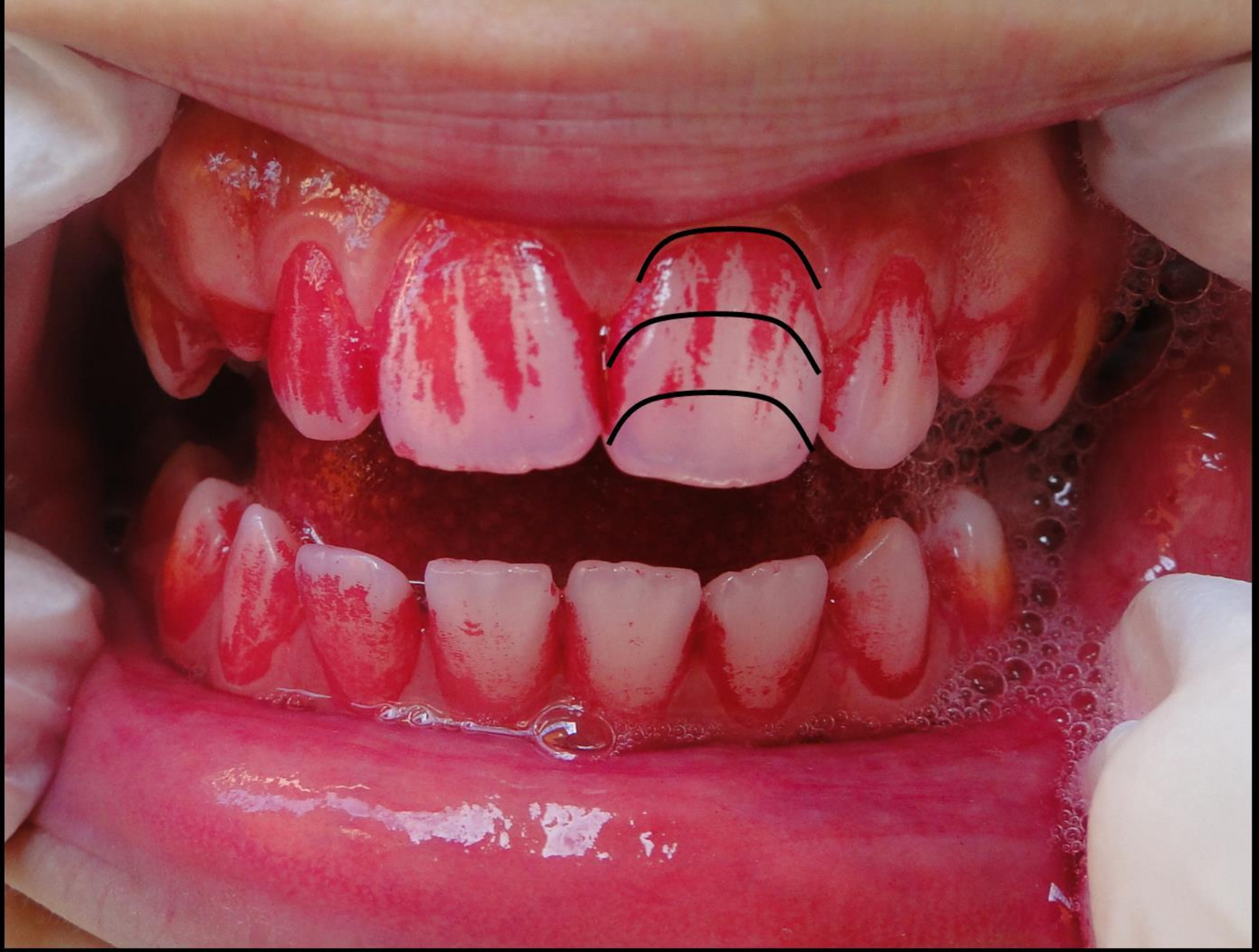
Índice para Placa $\frac{1+2+3+3+1+3}{6}$ 2,1

Índice para Cálculo $\frac{0+0+1+2+2+1}{6}$ 1,0

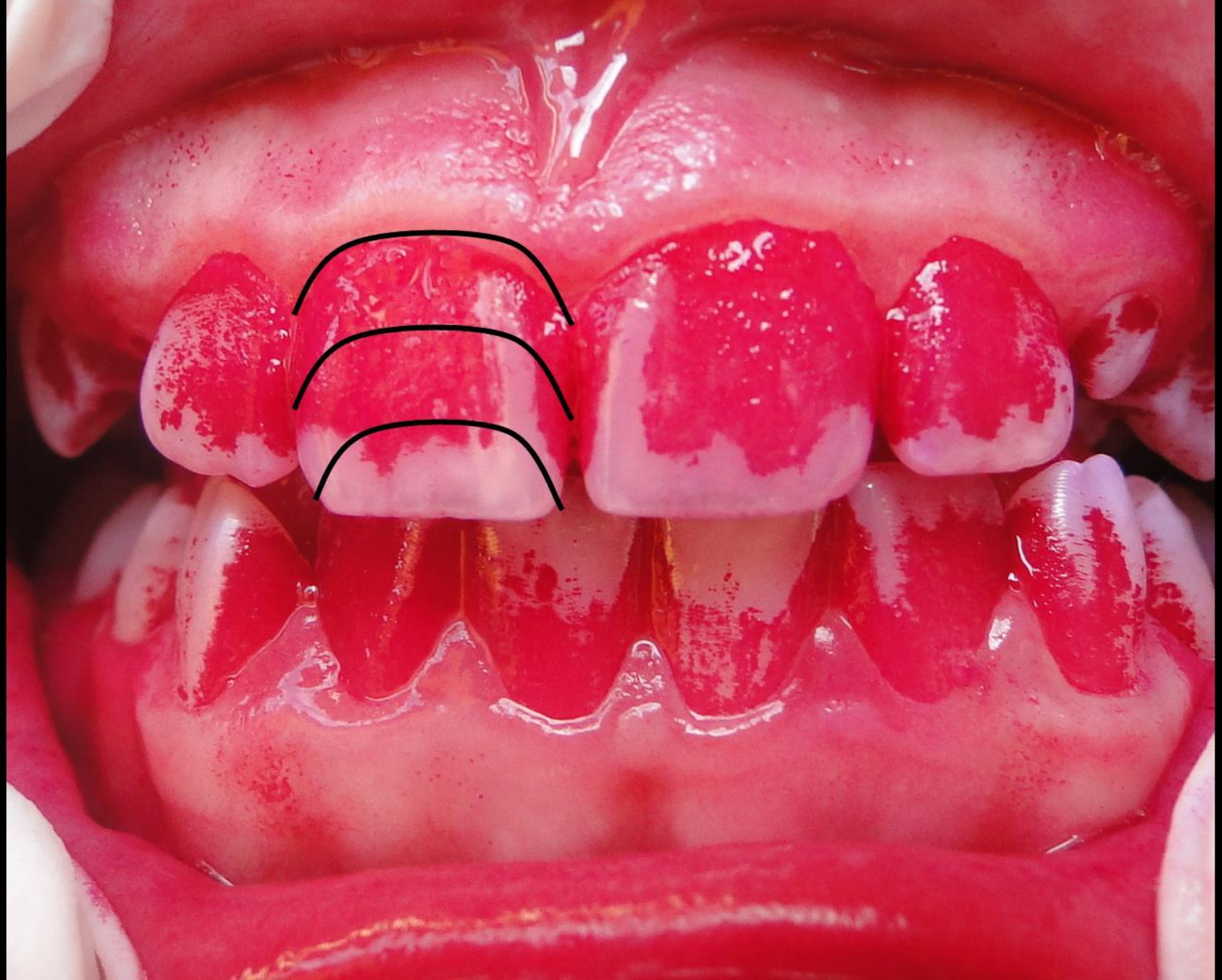
IHO - S = 2,1 + 1,0 = 3,1

- **0 a 1** → **HIGIENE ORAL SATISFATÓRIA**
- **1,1 a 2** → **REGULAR**
- **2,1 a 3** → **DEFICIENTE**
- **3,1 em diante** → **HIGIENE ORAL MUITO RUIM**

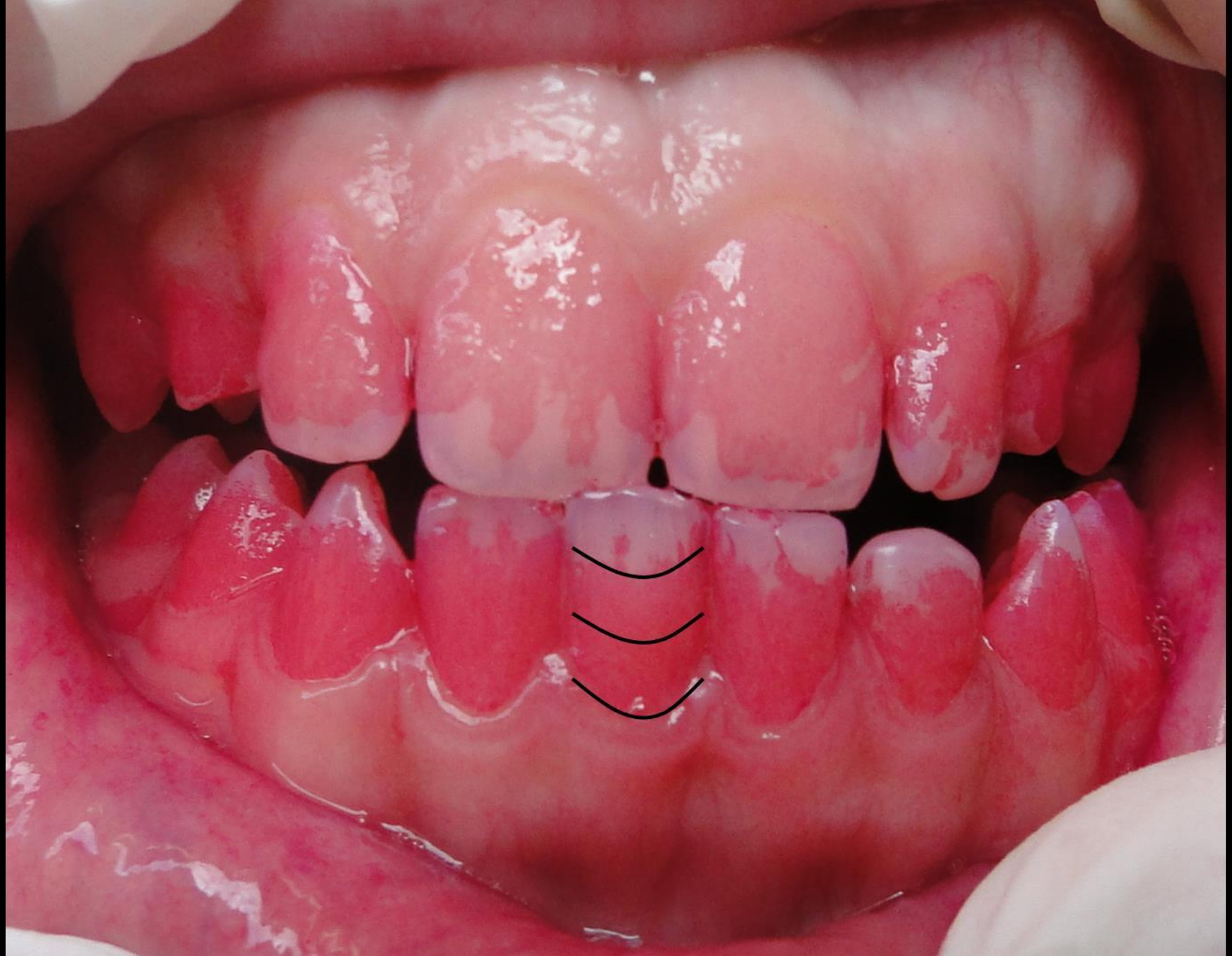
Em grupos, soma-se o índice de cada um e divide-se pelo total de pessoas examinadas.



Cód 1



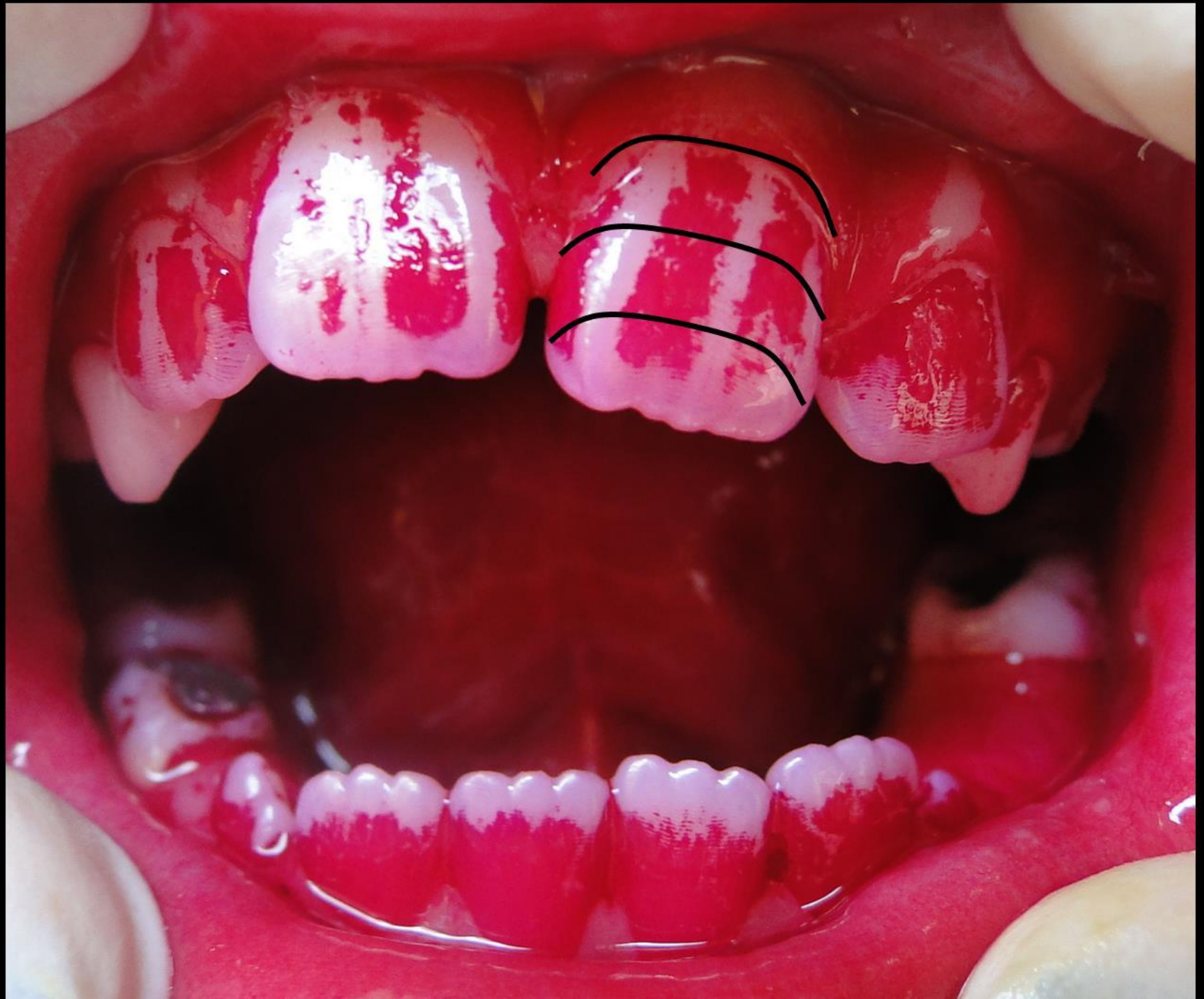
Cód 2



Cód 3



Cód 1



Cód 2

Cód 3

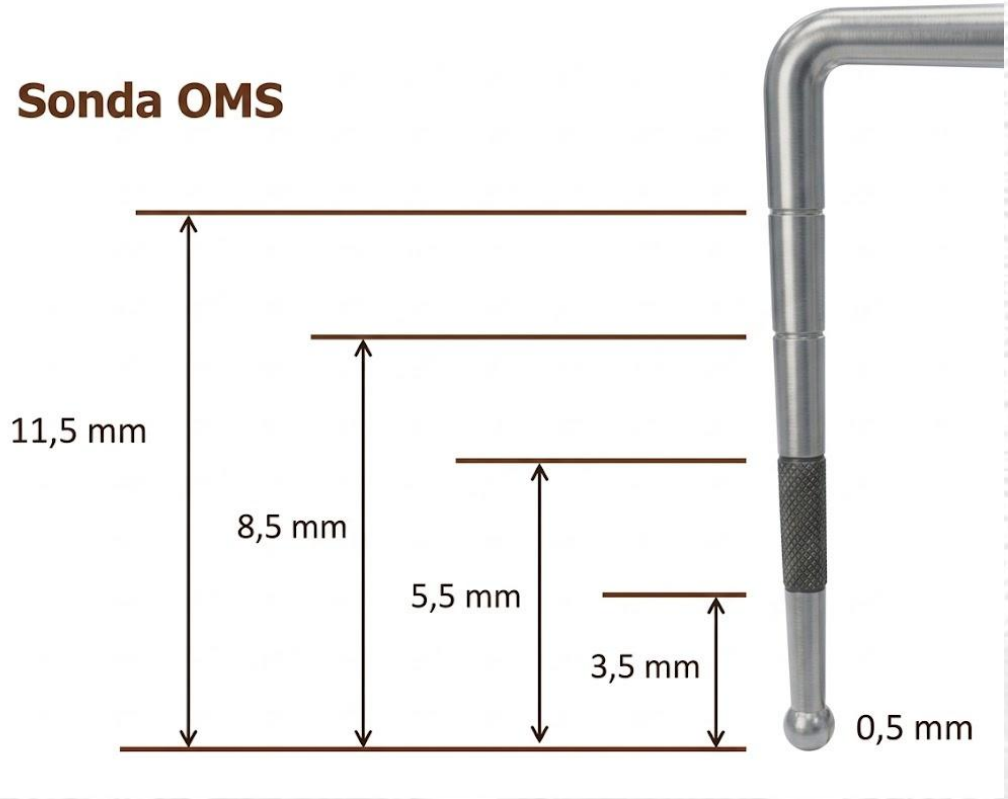


Condição periodontal

- **Condição periodontal:** Três indicadores de condição periodontal são usados para esta avaliação: Índice de Sangramento Gengival; Índice Periodontal Comunitário e Índice de Perda de Inserção.
- Uma sonda, preconizada pela OMS, especialmente desenhada, leve, de metal com uma ponta esférica é usada para avaliação periodontal.
- A sonda utilizada possui uma ponta esférica com 0,5 mm de diâmetro, com uma faixa preta que corresponde que compreende as medidas de 3,5 a 5,5 mm e anéis circulares a 8,5mm e 11,5 mm da ponta esférica.

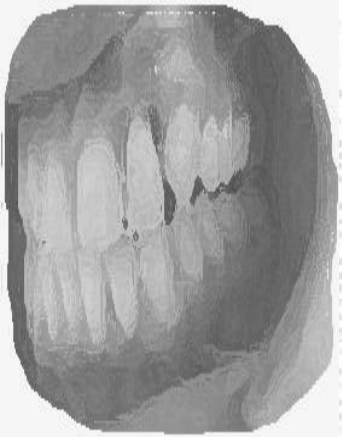








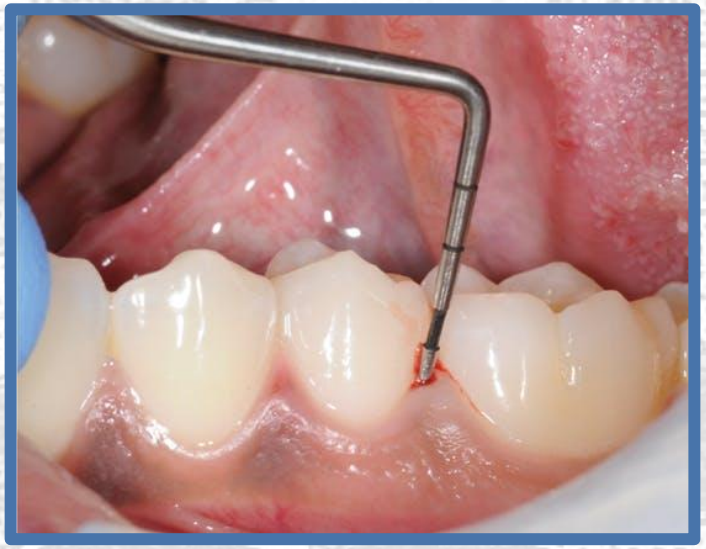




Índice de Sangramento após Sondagem

- Todos os dentes presentes na boca são examinados com relação à ausência ou presença de sangramento gengival.
- A esfera da sonda deveria ser inserida gentilmente no sulco gengival usando a força mais leve possível que permitirá o movimento da esfera da sonda ao longo da superfície do dente.
- A sonda periodontal percorre o sulco gengival, na direção das faces proximais, tanto por vestibular como por lingual.





Índice de Sangramento após Sondagem

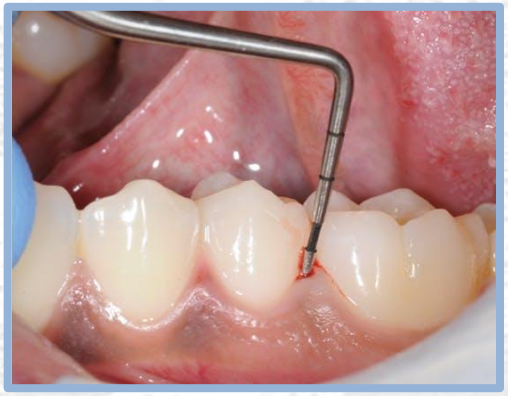
A gengiva de todos os dentes presentes na boca deveria ser examinada inserindo cuidadosamente a sonda OMS CPI entre a gengiva e o dente para avaliar à ausência ou à presença de sangramento à sondagem.

Códigos	Condições	Critérios
0	Ausência de sangramento	Quando não há sinal de sangramento ao exame.
1	Sangramento	Quando o dente apresenta sangramento após a sondagem.
9	Dente excluído	Um dente erupcionado que não pode ser examinado por quaisquer razões tais como bandas ortodônticas.
X	Dente ausente	Um dente não erupcionado ou perdido por qualquer motivo.

Exemplos



Código 0



Código 1

Índice de Sangramento após Sondagem

World Health Organization

Organização Mundial da Saúde

Ficha de Condição de Saúde Bucal de Crianças (segundo superfície dentária), 2013

Condição periodontal

55 54 53 52 51 61 62 63 64 65

17 16 15 14 13 12 11 21 22 23 24 25 26 27

(173) ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐ (186)

(187) ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐ (200)

85 84 83 82 81 71 72 73 74 75

47 46 45 44 43 42 41 31 32 33 34 35 36 37

Sangramentogengival
Escores
0 = Ausência de condição/sextante hígido
1 = Presença de condição
9 = Dente excluido
X = Dente ausente

Fluorose dentária ☐ (201)

Condição

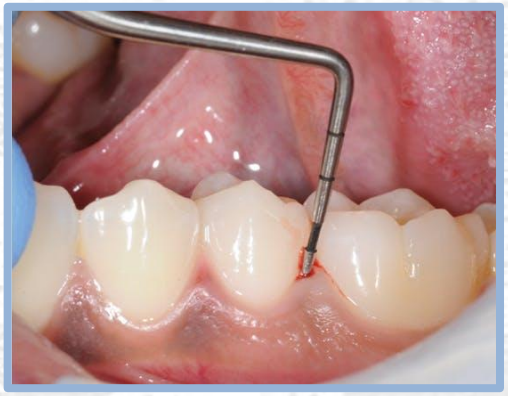
0 = Normal
1 = Questionável
2 = Muito leve
3 = Leve
4 = Moderada
5 = Severa

8 = Excluido (coroa, restauração, bráquete)
9 = Não registrado (dente não erupcionado)

Exemplos



Código 0



Código 1



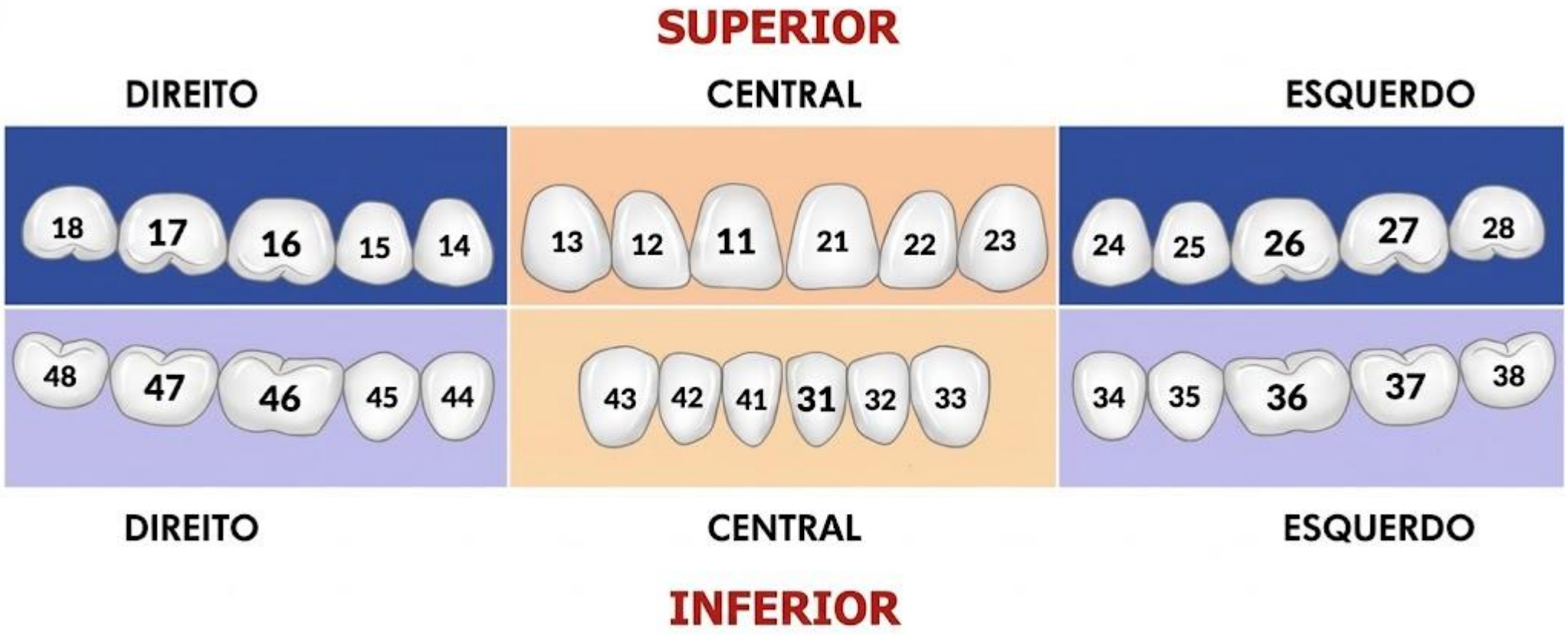
Índice Periodontal Comunitário

- O Índice Periodontal Comunitário permite avaliar a condição periodontal quanto à higidez, sangramento e presença de cálculo ou bolsa.
- Bolsas periodontais não são registradas em indivíduos menores de 15 anos de idade.



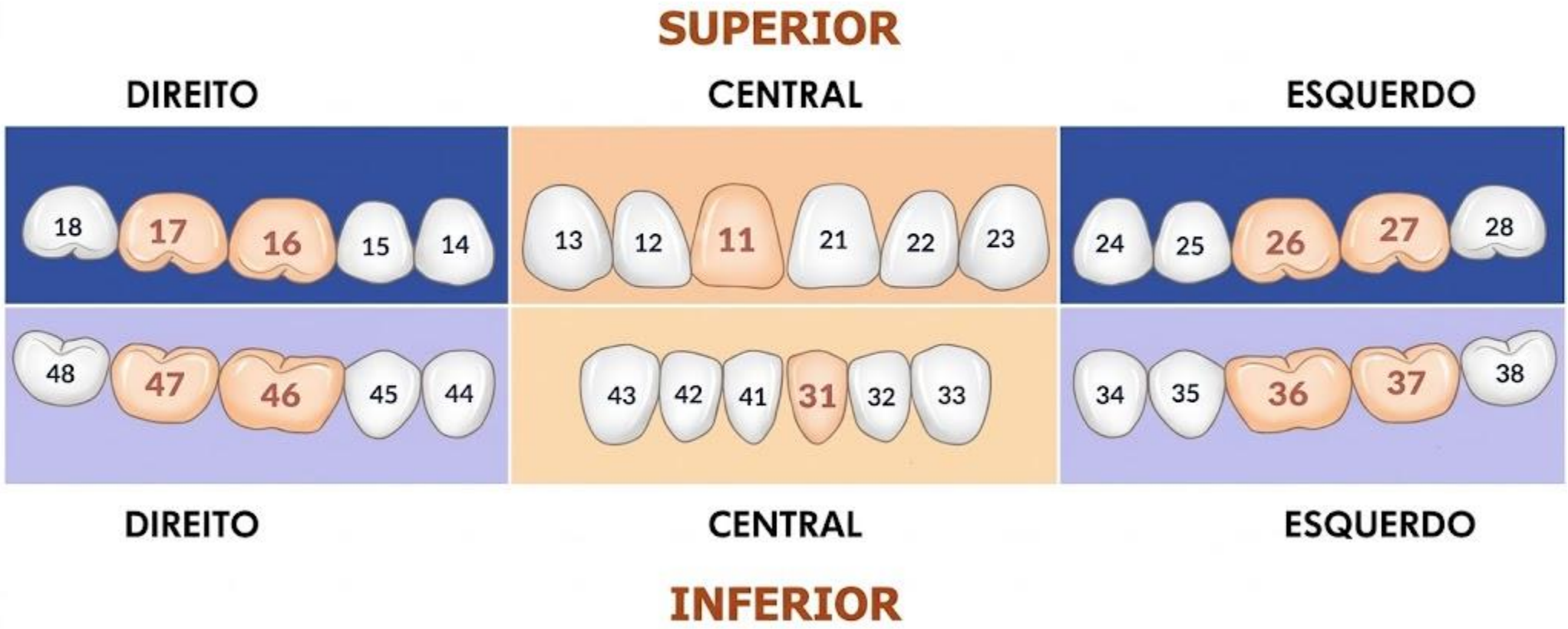
Índice Periodontal Comunitário

Os arcos são divididos em Sextantes



Índice Periodontal Comunitário

Os arcos são divididos em Sextantes e os dentes índices são



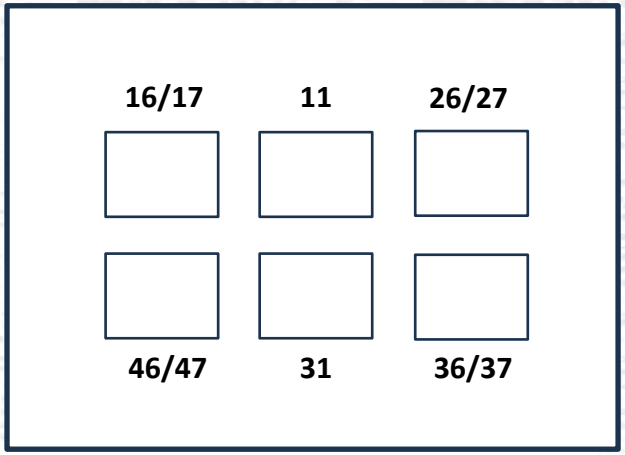
Índice Periodontal Comunitário

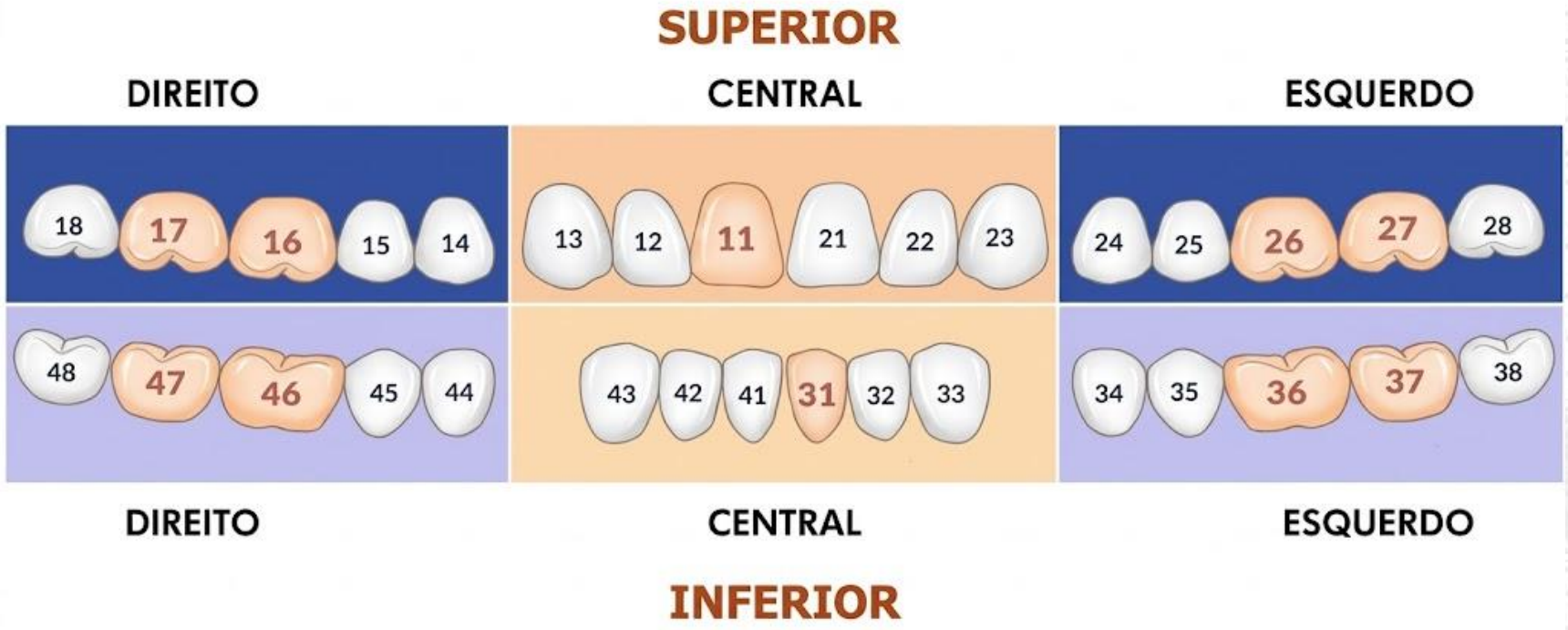
Registro do Índice Periodontal Comunitário	
Código	**Definição**
0	sextante hígido;
1	sextante com sangramento (observado diretamente após sondagem)
2	cálculo (qualquer quantidade, mas com toda a área preta da sonda visível)
3	bolsa de 4 mm a 5 mm (margem gengival na área preta da sonda)
4	bolsa de 6 mm ou mais (área preta da sonda não está visível)
X	sextante excluído (menos de 2 dentes presentes)



Índice Periodontal Comunitário

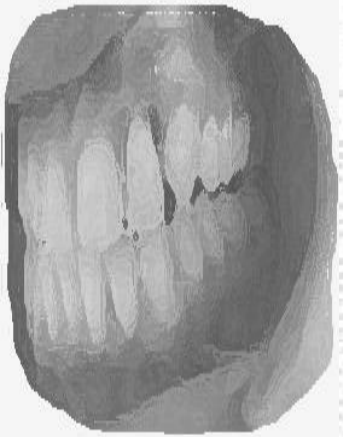
- 10 dentes examinados e 6 registros são feitos: um por sextante, relativo à pior situação encontrada.





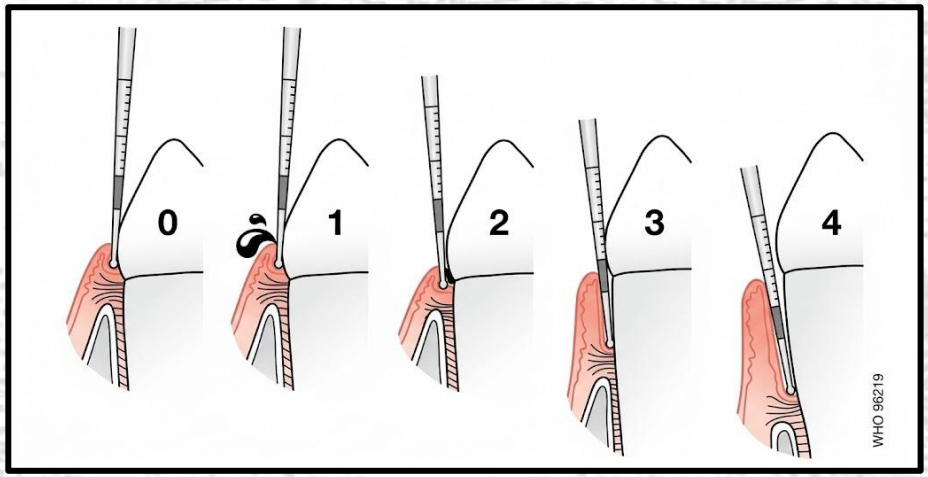


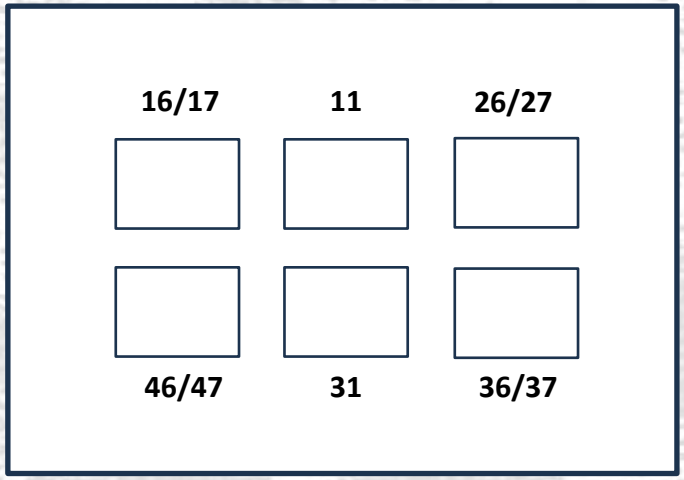




Índice Periodontal Comunitário

- A sonda deve ser introduzida levemente no sulco gengival ou na bolsa periodontal, ligeiramente inclinada em relação ao longo eixo do dente, seguindo a configuração anatômica da superfície radicular.
- Movimente a sonda gentilmente, com movimentos curtos para cima e para baixo, ao longo dos sulcos ou bolsas vestibulares.
- Se o participante que está sendo examinado sentir dor durante a sondagem, isso é indicativo de que está sendo utilizada força demais.

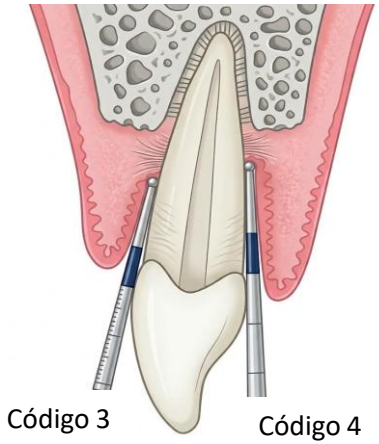




Índice Periodontal Comunitário

- Os procedimentos de exame devem ser iniciados pela área disto-vestibular, passando-se para a área média e daí para a área mésio-vestibular. Um procedimento similar é realizado para as superfícies linguais, começando na região disto-lingual do segundo molar.



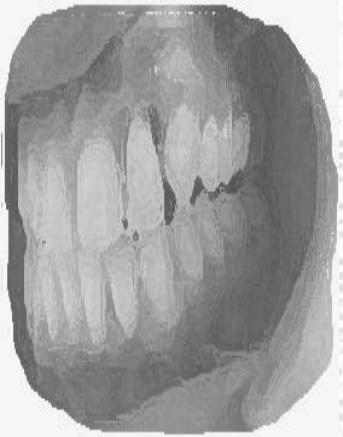












Índice Periodontal Comunitário



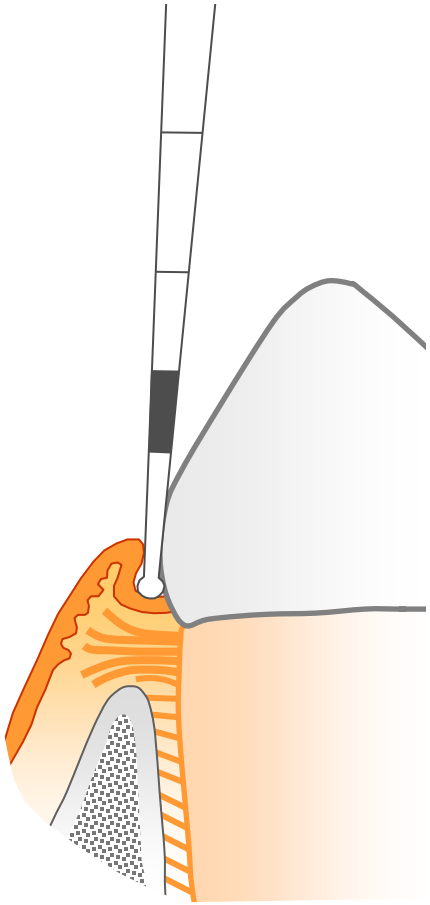
Pré-requisitos ao exame do sextante

- A presença de dois ou mais dentes sem indicação de exodontia (p. ex., comprometimento de furca, mobilidade vertical etc.)
- Nos sextantes posteriores, caso um dos molares esteja ausente, não será substituído, sendo examinado o molar remanescente.
- Se nenhum dente-índice estiver presente, outros dentes do referido sextante serão examinados e imputado a pior situação encontrada.
- Quando há, um único dente presente o sextante é excluído (X)

CÓDIGO – 0

Sextante hígido

Índice Periodontal Comunitário

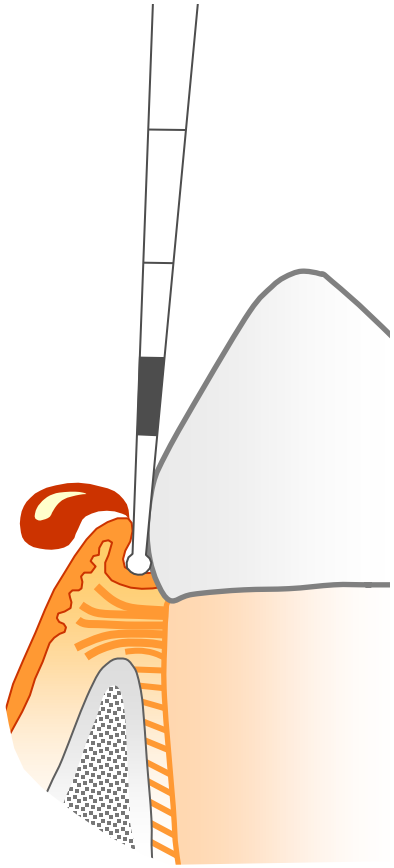




Índice Periodontal Comunitário

CÓDIGO – 1

Presença de sangramento observado após a sondagem

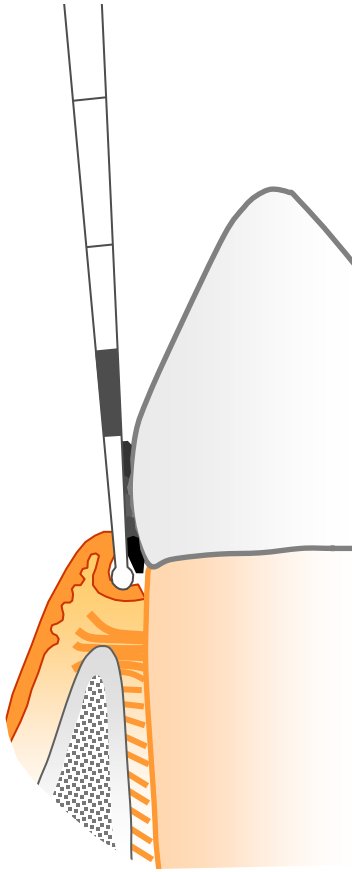




Índice Periodontal Comunitário

CÓDIGO – 2

Presença de cálculo e toda a área escura da sonda periodontal visível

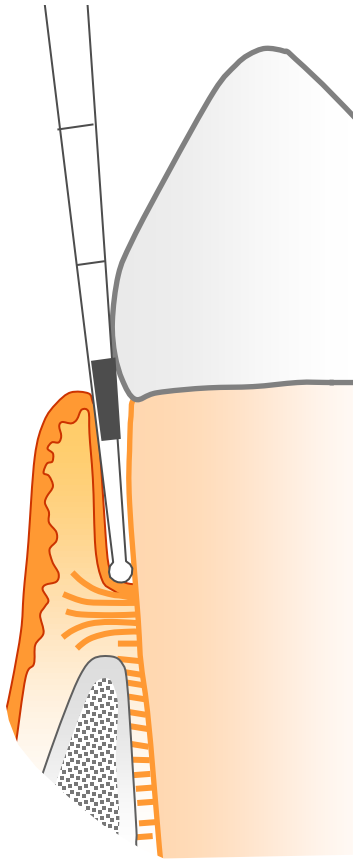




Índice Periodontal Comunitário

CÓDIGO – 3

Bolsa periodontal entre 4 – 5 mm (área escura da SP parcialmente visível)

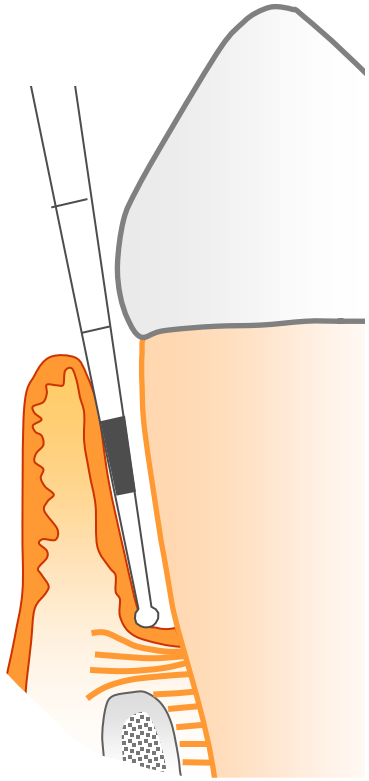




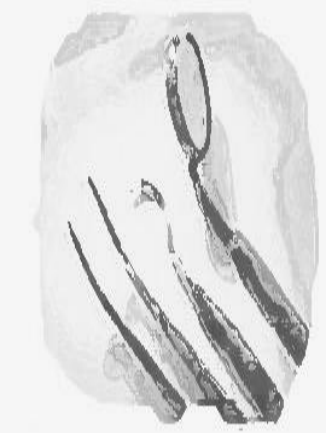
Índice Periodontal Comunitário

CÓDIGO – 4

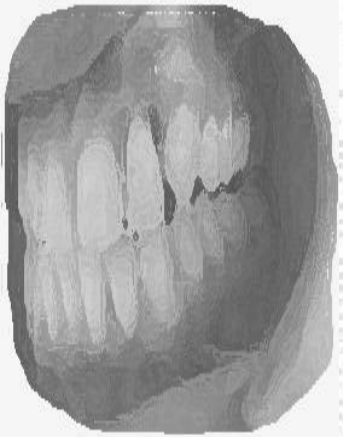
Bolsa periodontal de 6 mm ou mais (toda área escura da SP abaixo da margem gengival)









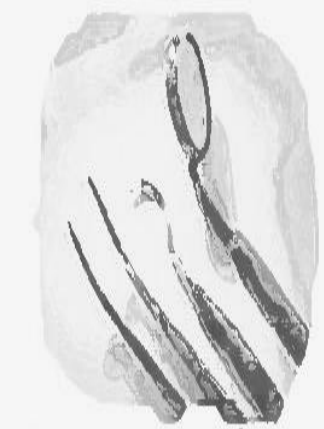


Índice de Perda de Inserção Periodontal - PIP

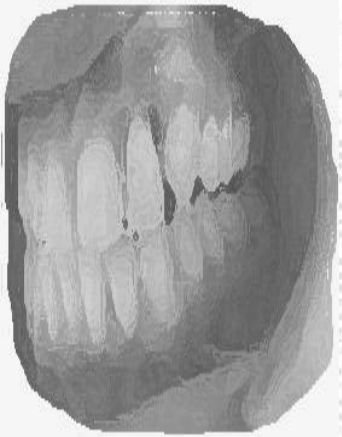
- O índice permite avaliar a condição da inserção periodontal,
- A inserção periodontal é medida da junção amelocementária até o limite máximo do sulco gengival

Relação com CPI – O PIP é basicamente um complemento do CPI.

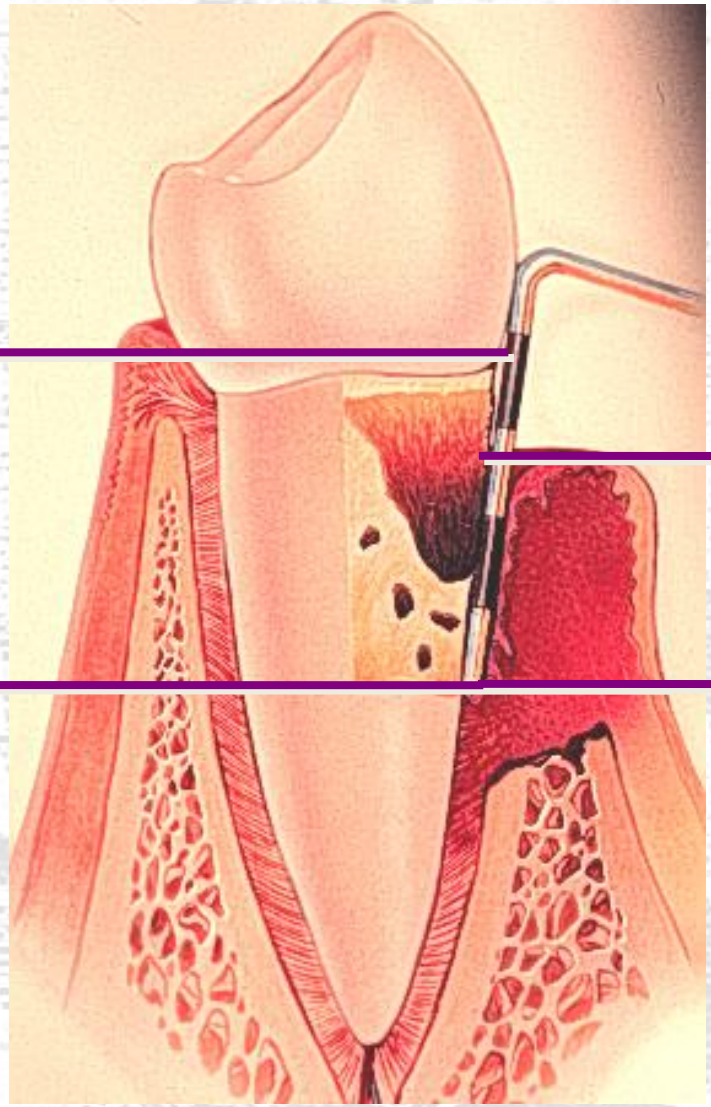
- Os mesmos sextantes e dentes-índices são considerados, sob as mesmas condições.
- É utilizada o mesma sonda.
- A visibilidade da JCE é a principal referência para o exame.







Índice de Perda de Inserção Periodontal - PIP

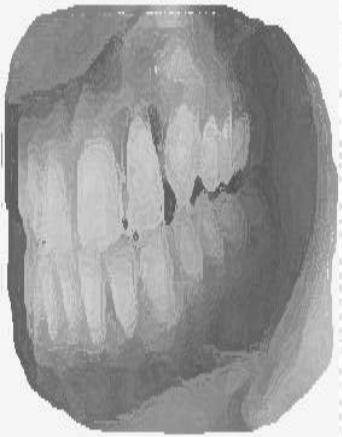


Perda da inserção

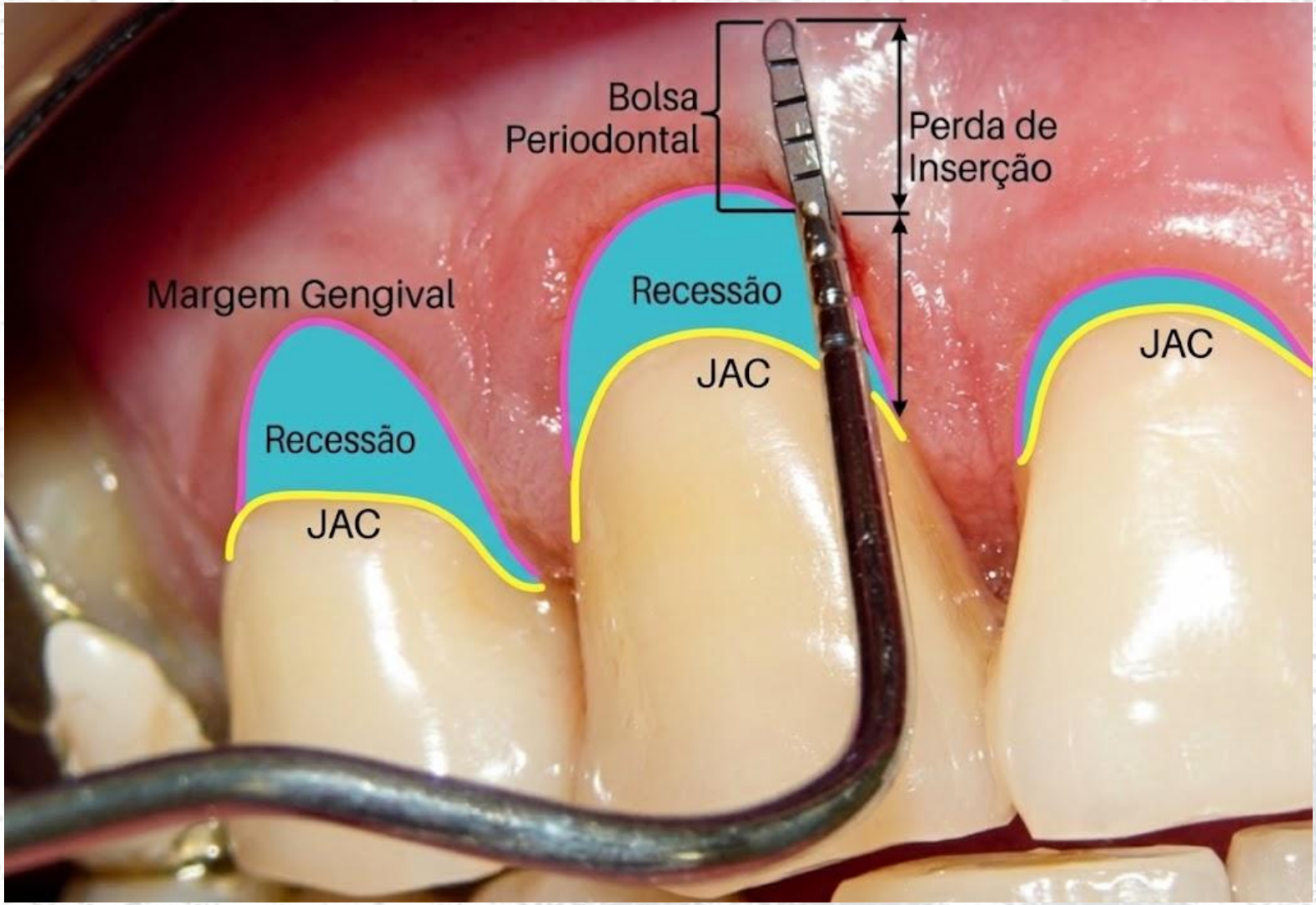
Profundidade da bolsa periodontal





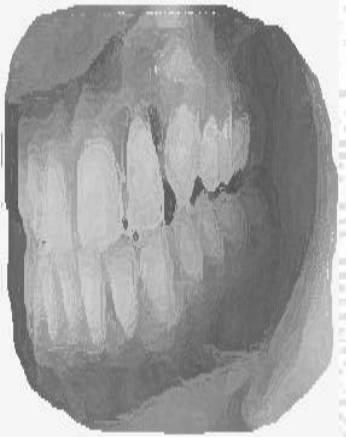


Índice de Perda de Inserção Periodontal - PIP









Índice de Perda de Inserção Periodontal - PIP

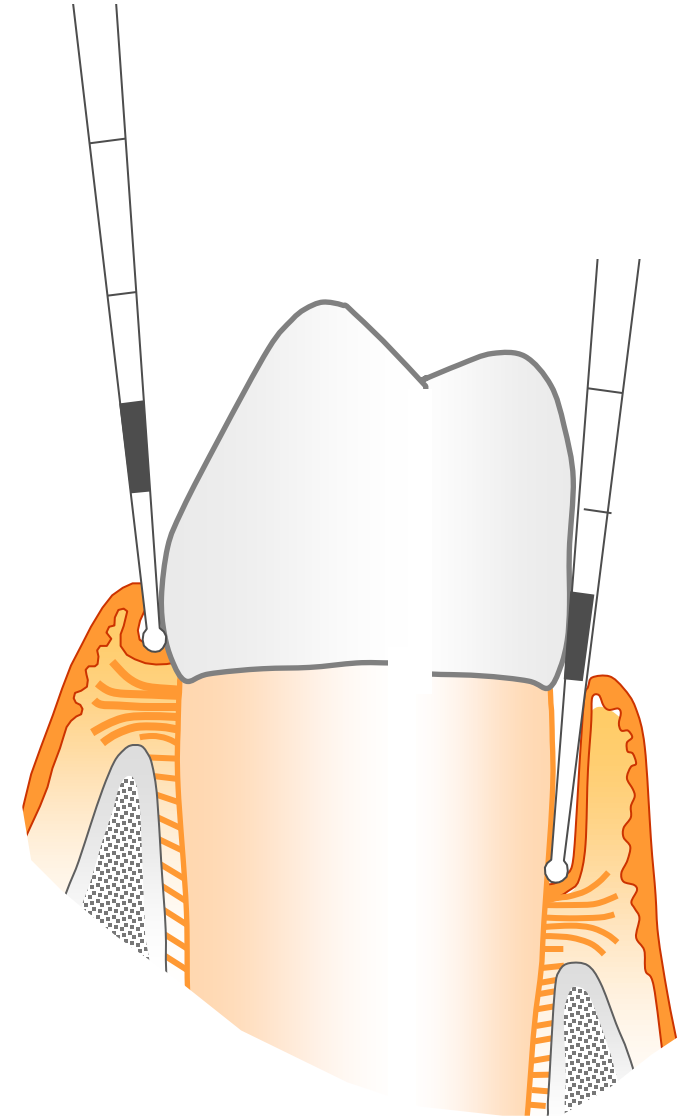
- O índice *Perda de Inserção Periodontal* permite avaliar a condição da inserção periodontal

Registro do Índice Periodontal Comunitário	
Código	**Definição**
0	**Perda de inserção de 0 a 3 mm**
1	**Perda de inserção de 4 a 5 mm**
2	**Perda de inserção de 6 a 8 mm**
3	**Perda de inserção de 9 a 11 mm**
4	**Perda de inserção de 12 mm ou mais**
X	**sextante excluído (menos de 2 dentes presentes)**
9	**sextante não examinado**

Índice de Perda de Inserção Periodontal - PIP

0 Perda de Inserção entre 0 e 3 mm

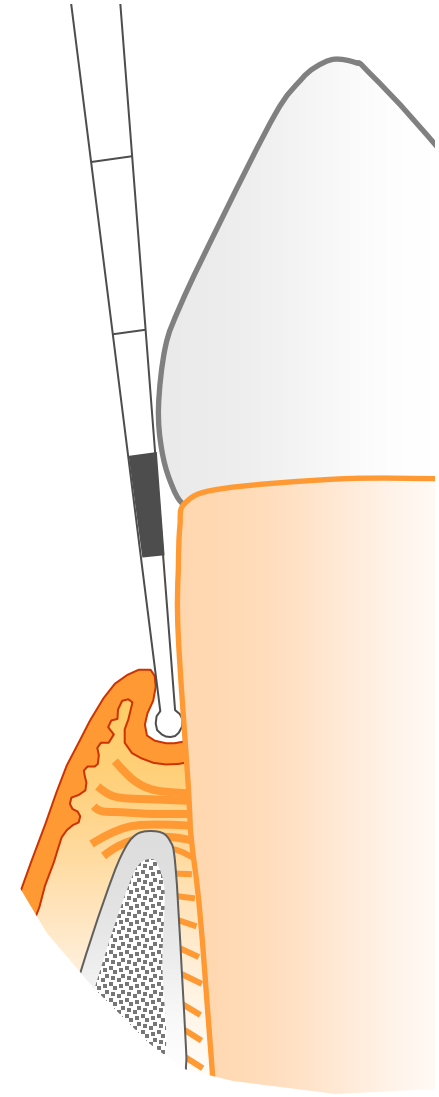
JCE não visível e sonda CPI entre 0 e 3



Índice de Perda de Inserção Periodontal - PIP

1 Perda de Inserção entre 4 e 5 mm

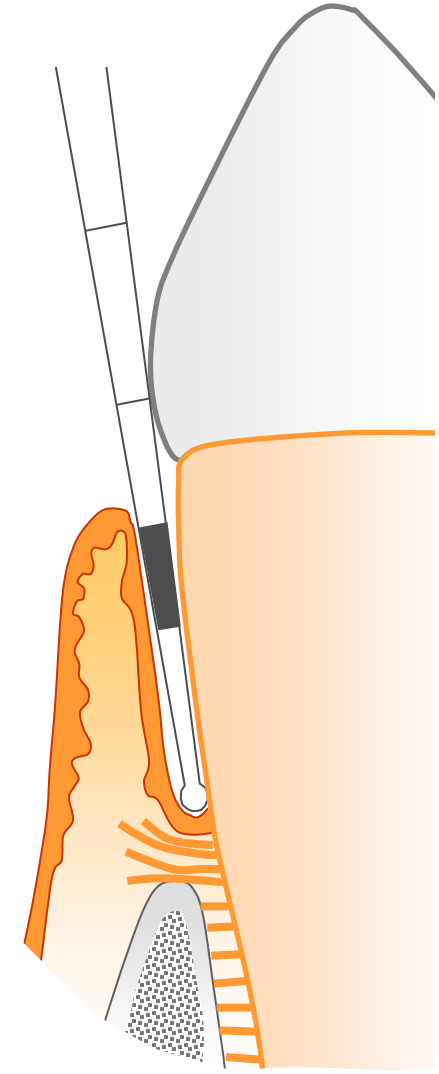
JCE visível na área preta da sonda CPI



Índice de Perda de Inserção Periodontal - PIP

2 Perda de Inserção entre 6 e 8 mm

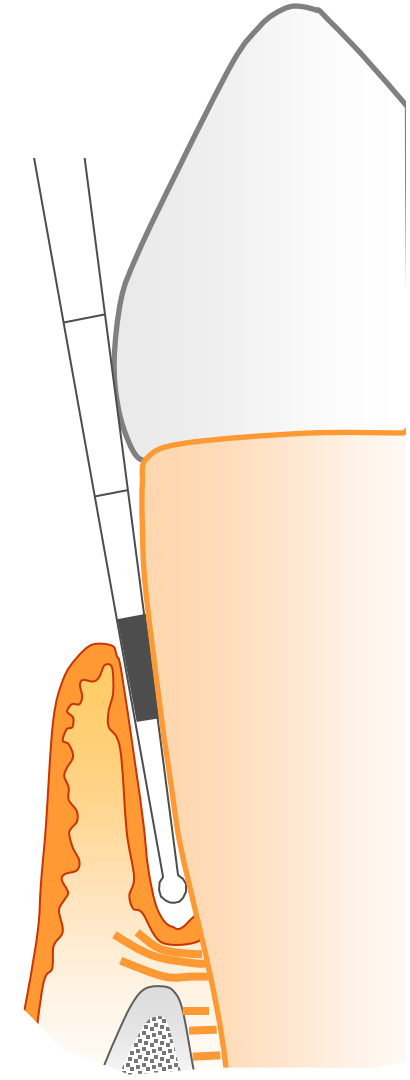
JCE visível entre limite superior da área preta da sonda CPI e a marca de 8,5 mm



Índice de Perda de Inserção Periodontal - PIP

3 Perda de Inserção entre 9 e 11 mm

JCE visível entre as marcas de 8,5 mm e 11,5 mm

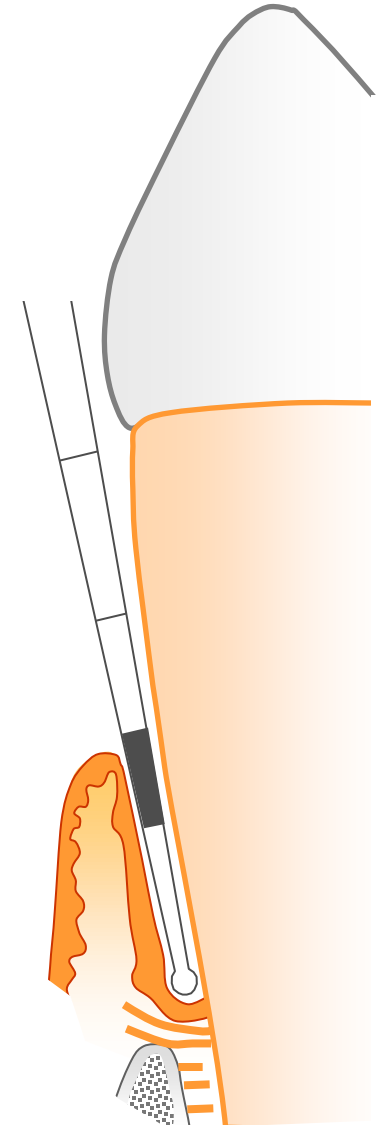


Índice de Perda de Inserção Periodontal - PIP

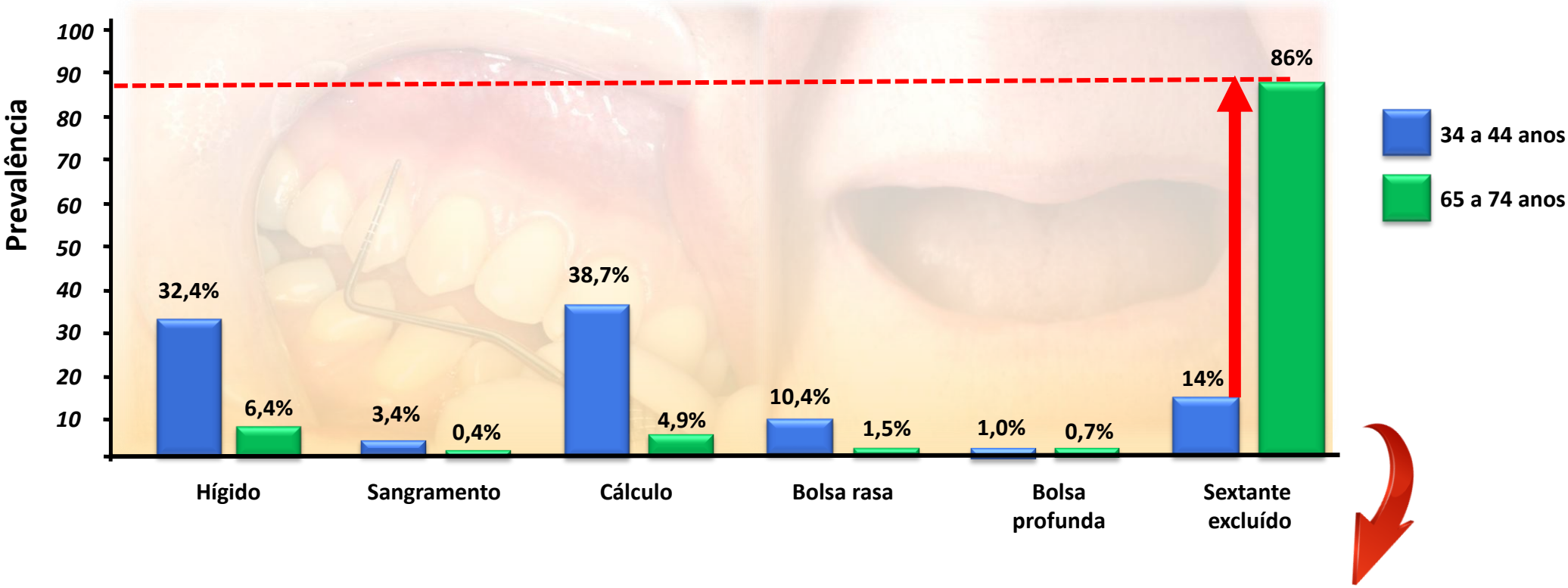
4 **Perda de Inserção de 12 mm ou mais**
JCE visível além da marca de 11,5 mm

X **Sextante Excluído**
menos de 2 dentes presentes

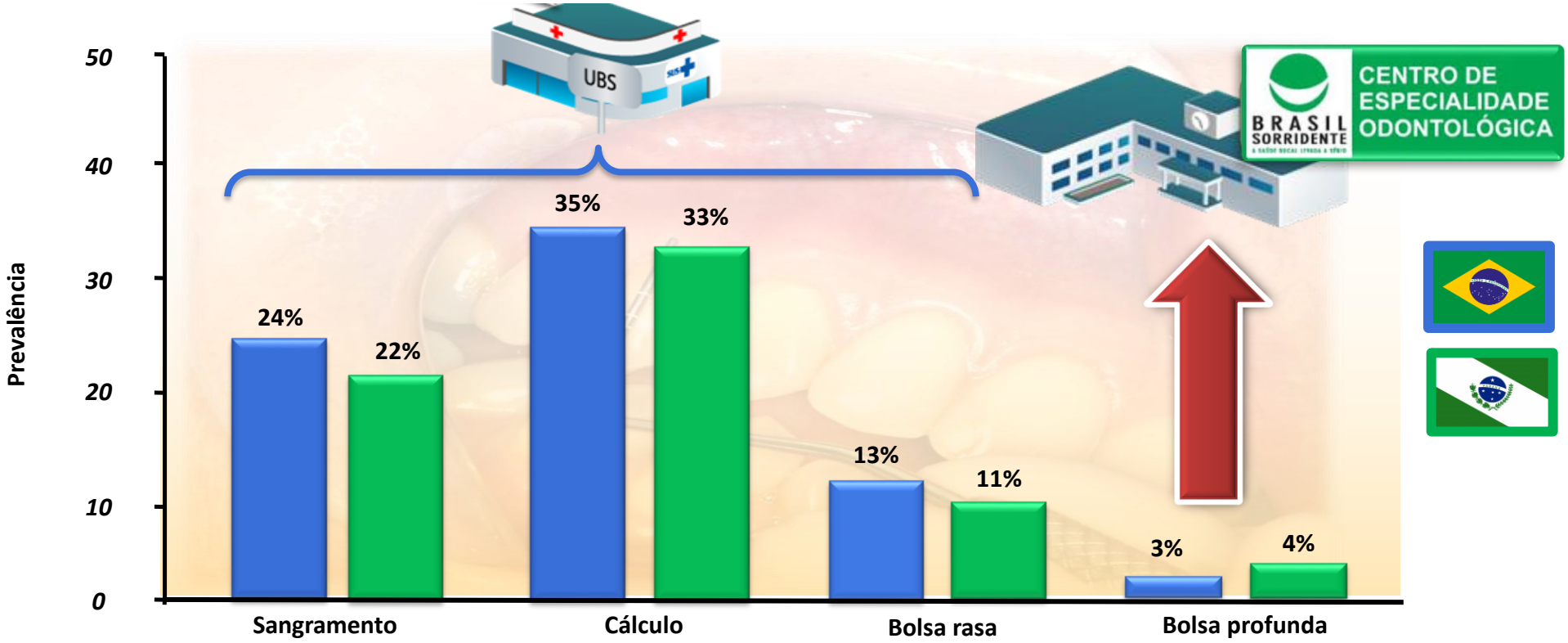
9 **Sextante Não Examinado**



Percentual de participantes com idades entre **34 a 44** e **65 a 74** anos de acordo com o pior escore do Índice Periodontal Comunitário no Brasil e por regiões brasileiras, no ano de 2023



Percentual de participantes de 65 a 74 anos de idade com sangramento à sondagem, cálculo, bolsa periodontal rasa ou profunda no Brasil e região Sul, no ano de 2023



Profundidade de sondagem entre 4 e 5 mm (localizada - UBS ou generalizada - CEO).